

Hemorragia pós-parto · 4T

HPP primária: perda "e 500 mL no vaginal ou "e 1000 mL na cesárea (ou qualquer perda com repercussão). Atonia é a causa nº 1 — massageie e use uterotônicos cedo.

Os 4T

T | Causa | Conduta-chave

Tônus | Atonia uterina | Massagem bimanual + ocitocina / metilergometrina / misoprostol

Trauma | Laceração, ruptura, hematomas | Revisão de canal + sutura

Tecido | Restos placentários / acretismo | Remoção / curetagem / acretismo = centro

Trombina | Coagulopatia | Protocolo de transfusão / fatores

Escalonamento

- Ocitocina EV é 1ª linha; evitar ergometrina em HAS/pré-eclâmpsia
- Balão intrauterino (Bakri) se atonia refratária
- Suturas de compressão (B-Lynch), ligadura vascular, embolização
- Histerectomia como último recurso para salvar a vida

Prevenção

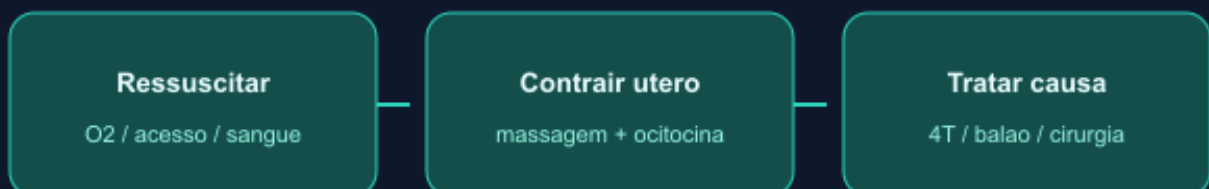
Lembre - Prevenção

Manejo ativo do 3º período (ocitocina após ombro anterior / dequitação conforme protocolo) reduz HPP.

Simultâneo: ressuscitar, contrair o útero e tratar a causa dos 4T.

HPP - conduta inicial

ABC + utero + causa (4T)



Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Útero contraído + sangramento persistente !' procure laceração de colo/vagina ou coagulopatia; não 'só mais ocitocina'.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1